**Poder Judiciário**
**Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul**
**Vara Judicial da Comarca de Garibaldi**

Rua Francisco Menegheti, 130 - Bairro: Centro - CEP: 95720000 - Fone: (54) 3022-9843 - Balcão virtual 54-99959-4785 - Email: frgaribaldvjud@tjrs.jus.br

**PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002157-08.2021.8.21.0051/RS**

**AUTOR**: IZABEL CRISTINA RODRIGUES BIAVASCHI

**AUTOR**: ANDREY BIAVASCHI BARRETO PEREIRA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC))

**RÉU**: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# SENTENÇA

**1.- Relatório [Artigo 489, inciso I, do Código de Processo Civil].**

**ANDREY BIAVASCHI BARRETO PEREIRA**, representado por sua genitora IZABEL CRISTINA RODRIGUES BIAVASCHI e propõe *ação para fornecimento de medicação* que não está incluída na lista do SUS, onde o autor narra ter sido diagnosticado com Transtorno do espectro autista (CID F84.0) e Transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade (CID F90.0). Disse que, em razão de sua enfermidade, necessita recorrer ao uso do fármaco Venvanse 30mg, ministrado um comprimido ao dia (30 cápsulas/mês), de forma contínua e por tempo indeterminado, nos moldes do laudo médico juntado em evento 1, DOC8. Requer, em sede antecipatória do mérito, o fornecimento do medicamento pela parte requerida, ou o valor em dinheiro para sua aquisição. No mérito, a confirmação dos efeitos da tutela antecipada, pelo tempo necessário para o tratamento. Instruiu com documentos.

Decisão de evento 3, DOC1, que recebe a inicial, defere o pedido de tutela antecipada.

O Estado do Rio Grande do Sul contestou o pedido em evento 34, DOC1. Defendeu a responsabilidade da União para fornecimento dos medicamentos não incluídos na lista do SUS, postulando pela sua inclusão no polo passivo da demanda. Discorreu sobre a capacidade financeira da parte autora em arcar com os insumos postulados. Requereu a improcedência do pedido.

A parte autora, em réplica, reitera os argumentos trazidos na inicial, evento 38, DOC1.

Sobreveio laudo pericial, evento 167, DOC1, evento 167, DOC2, evento 167, DOC3.

O Ministério Público, em parecer, evento 189, DOC1, manifestou-se pela procedência do pedido.

Vieram os autos conclusos para sentença.

**É o relatório. Passo à motivação.**

**2.- Fundamentos [Art. 489, inciso II, do CPC].**

Cuida-se de ação em que o autor postula a condenação do requerido a fornecer os medicamentos para tratamento da patologia que o acomete.

A matéria discutida nestes autos é pacífica na jurisprudência do TJ/RS e das Cortes Superiores. O direito à saúde está previsto no art. 196 da Constituição Federal como sendo acessível a todos e dever do Estado, em todas as esferas de governo, cabendo igualmente à União, aos Estados e aos Municípios, de forma solidária, a elaboração de políticas públicas voltadas a sua promoção e preservação, no que se inclui a dispensação de fármacos àqueles que não têm condições de adquiri-los com recursos próprios, assim como de atendimento médico, hospitalar e cirúrgico.

A legislação infraconstitucional também é generosa ao garantir a defesa ao direito à saúde (art. 15 do Estatuto do Idoso; art. 2º da Lei 8.808/90; art. 241 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul; dentre outros exemplos).

Como decorrência da solidariedade existente entre os entes da Federação, pode a parte autora optar por demandar contra qualquer um deles, em conjunto ou separadamente, em face do que tanto um quanto o outro é legitimado a figurar no polo passivo. Eventual divisão de competências realizada no âmbito do Sistema Único de Saúde não se sustenta em oposição ao direito fundamental à saúde e, consequentemente, à vida.

Assim, não há dúvidas de que compete aos entes federados, solidariamente, a responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos visando a assistência à saúde.

É incontroverso o dever do Estado (*lato sensu*) garantir aos cidadãos carentes o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, dentre os quais está incluída a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, de forma gratuita.

Nesse aspecto, a Lei estadual nº 9.908/1993 regulamenta a disponibilização de fármacos excepcionais (aqueles "*que devem ser usados com frequência e de forma permanente, sendo indispensáveis à vida do paciente*"; parágrafo único do art. 1º) e dispõe, em seu art. 1º, que "*O Estado deve fornecer, de forma gratuita, medicamentos excepcionais para pessoas que não puderem prover as despesas com os referidos medicamentos, sem privarem-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família*".

Destarte, uma vez demonstrada a necessidade de utilização do fármaco e a impossibilidade econômica do postulante arcar com o tratamento por conta própria, bem como existindo elemento de prova de que o medicamento indicado para tratamento da patologia não pode ser substituído por outro – claro que essa situação deve ser suficientemente justificada pelo médico que acompanha o paciente –, configurada está a responsabilidade do Estado (lato sensu) à concessão.

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a **presença cumulativa dos seguintes requisitos:**

**(i)** *Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento***,** *assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*

**(ii)** *incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;*

**(iii)** *existência de registro na ANVISA do medicamento.*

Não há controvérsia sobre o estado de saúde do autor, considerando o laudo do médico assistente (evento 1, DOC8), em que aponta a doença e o tratamento necessário, bem como o laudo pericial (evento 167).

No caso dos autos, evidente a necessidade da utilização do medicamento postulado, bem como o risco pelo não uso, circunstância que pode levar o requerente à **piora comportamental, risco de auto e heteroagressão.**

Outrossim, eventual possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros disponíveis na rede pública foi devidamente afastada pelo laudo médico:

- HISTÓRICO DO TRATAMENTO: **Especificar quais** medicamentos/insumos já foram utilizados pelo(a) paciente e porque não foram eficazes no combate da patologia, bem como quais os efeitos colaterais produzidos no organismo do paciente(a):
Metilfenidato. Não houve resposta satisfatória mesmo com dosagem adequada para o peso.

- **Justificar** a razão pela qual não prescreve os fármacos/insumos integrantes das listas padronizadas do **SUS** e/ou dos Protocolos Clínicos:
Já foi utilizada a única possibilidade que é o Metilfenidato

Não bastasse isso, o laudo pericial de evento 167 atestou os transtornos do requerente, respondendo aos quesitos das partes e referindo a indicação correta da medicação pretendida.

k) O menor necessita de terapias e tratamento farmacológico de forma contínua e por tempo indeterminado e, dentre os medicamentos utilizados por Andrey, o Venvanse determinou os melhores resultados em termos de hiperatividade e desatenção.

O requisito atinente à hipossuficiência econômica do grupo familiar do autor também restou demonstrado, eis que, conforme demonstram os documentos juntados em evento 72 e evento 73 obtêm renda mensal próxima a dois salários mínimos, auferindo renda insuficiente a custear o tratamento do menor, o qual ultrapassa os R$ 340,00 mensais.

Destarte, não restam dúvidas de que o medicamento pleiteado é indispensável ao seu tratamento. E, não sendo atendido a tempo a solicitação da demandante, passível de perecimento o próprio direito à qualidade de vida, pois esta se trata de pessoa comprovadamente dependente do tratamento.

É verdade que se trata de medicamento caro, que onera sobremaneira os entes públicos, e todos sabemos que os recursos são limitados, há demandas inúmeras, ordem de prioridades, necessidade de regulação de um sistema universal e único, sujeito a controle, que não prescinde da observância de isonomia de atendimento entre cidadãos [alargar direito a um, pode significar sacrifício de uma coletividade].

Mas a amplitude constitucional e infraconstitucional atribuída ao tema é de garantia do direito social à saúde, o entendimento jurisprudencial é pacífico, daí só resta ao juízo fazer alguma ressalva de entendimento em determinados casos, mantida a declaração do direito por racionalidade judiciária, por visão sistêmica do sistema de Justiça e de garante de direitos.

O fornecimento do medicamento deve observar a denominação comum brasileira.

**3.- Dispositivo [Art. 489, inciso III, do CPC].**

**Isso posto**, confirmo a tutela de urgência deferida e JULGO **procedente** o pedido para condenar o requerido a fornecer ao autor o fármaco Venvanse 30mg, ministrado uma vez ao dia (30 cápsulas/mês), de forma contínua e por tempo indeterminado, enquanto perdurar a sua necessidade.

A parte demandante deverá entregar ao requerido atestado médico semestral que comprove que a necessidade do medicamento persiste.

Condeno o requerido ao pagamento da taxa única dos serviços judiciais e honorários advocatícios devidos ao procurador da parte contrária, que fixo em 10% do valor da causa, atentando aos parâmetros do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho desempenhado e da natureza da demanda.

Interposta(s) apelação(ões), intime(m)-se o(s) apelado(s) para contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias. Havendo preliminares nas contrarrazões, intime(m)-se o(s) apelante(s) para manifestação (prazo 15 dias). Caso interposta apelação adesiva pelo apelado, intime-se o apelante para contrarrazões, querendo (prazo 15 dias).

Tudo cumprido, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do RS, na forma do artigo 1.010 do CPC.

Transitada em julgado, nada pendente, arquive-se com baixa.

---

Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO LUIZ PEREIRA ROSA, Juiz de Direito**, em 4/6/2024, às 9:18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10059894234v6** e o código CRC **1469d519**.

---